

Chapitre II

Apport de la psychopathologie du travail à l'étude d'une bouffée délirante aiguë

Annie Bensaïd¹

Cette étude est consacrée à un cas clinique analysé à la lumière de la psychopathologie du travail. Cette discipline, telle est notre hypothèse, peut aider à la compréhension, voire au traitement de certaines décompensations psychiatriques.

L'histoire de M. S., ouvrier du bâtiment, met en évidence deux types de contraintes différenciées :

- d'une part, les contraintes engendrées par les rapports sociaux et l'organisation du travail. L'adaptation psychique à de telles contraintes met en jeu une idéolo-

1. Annie Bensaïd est psychiatre et psychanalyste.

gie défensive de métier renvoyant au collectif de travail ;

– d'autre part, les contraintes engendrées par les relations intersubjectives à l'intérieur de sa famille, qui impliquent des défenses renvoyant à l'ordre individuel.

Entre ces deux types de stratégies défensives surgissent parfois des contradictions insolubles qui pourraient jouer un rôle déterminant dans les ruptures de l'équilibre psychique. J'essaierai de montrer comment l'analyse de ces défenses a eu une incidence sur l'orientation thérapeutique dans une voie qui n'aurait pas pu être pensée sans référence à la psychopathologie du travail.

CAS

M. S. est un homme de 40 ans, que je reçois aux urgences à la demande d'un médecin généraliste pour une symptomatologie délirante de type persécutif à mécanismes interprétatifs et hallucinatoires, évoluant depuis trois mois. Il avait lui-même spontanément consulté quinze jours auparavant, ayant le sentiment de « devenir fou ». Jusque-là, M. S. n'avait jamais eu recours aux médecins et encore moins aux psychiatres.

Il se présente d'emblée comme un homme sympathique, chaleureux et relate ses difficultés sans aucune réticence alors même que la persécution est au centre de sa problématique actuelle. Il a donc un bon contact malgré une angoisse majeure, se manifestant par une logorrhée et une trémulation des extrémités. L'imprégnation alcoolique est certaine – récente, dit-il. En effet, il ne présente pas d'*habitus* d'intoxication chronique (le bilan biologique effectué quelque temps plus tard le confirmera).

Sa demande est claire : outre son souhait d'être rassuré sur le risque d'être fou, il veut vivre « calmement avec sa famille ».

D'origine marocaine, seul en France depuis dix-sept ans, il travaille comme peintre en bâtiment. Son histoire psychopathologique débute un an après l'arrivée de sa femme et de ses filles en France. Depuis quelques mois, M. S. est irritable, nerveux, tant sur son lieu de travail qu'à son domicile, violent avec sa femme, qu'il bat. Il regrette cette conduite, pleure et consomme de l'alcool dans un but anxiolytique.

Se développent dans le même temps des idées de référence : il a le sentiment d'être suivi, observé dans la rue, dans le RER qui le conduit à son travail, où il a la conviction qu'on parle de lui. Il pense que ses voisins et son concierge le surveillent. À cette époque, il sera convoqué par l'assistante sociale de secteur, suite à un signalement du gardien, en raison des violences qu'il exerce sur sa famille. Il sera alors conclu que M. S. présente un alcoolisme, dans un contexte de difficultés *classiques* d'adaptation des immigrés maghrébins, en particulier avec une dangerosité pour ses enfants. Une mesure d'AEMO (Assistance éducative en milieu ouvert) sera envisagée pour les protéger, mesure fréquente dans la pratique psychiatrique ordinaire (soulignons que, dans le cadre de cette interprétation des conduites pathologiques de M. S., il est étonnant que la prise en charge proposée d'emblée par un médecin femme n'ait occasionné aucune difficulté particulière).

L'origine des troubles est donc rapportée à sa condition d'immigré, voire à une structure préexistante (per-

sonnalité paranoïaque) sans référence aux questions de travail, en particulier de l'organisation du travail. Incompréhension qu'il supporte difficilement puisqu'il sait, lui, qu'il a changé (aucun problème d'adaptation durant dix-sept ans), au point qu'il ne se reconnaisse plus lui-même. Il est anxieux à son travail, renfermé, se bagarre pour la première fois sur un chantier.

Trois mois avant cette première consultation, il a eu un accident du travail : chute d'un échafaudage. Il s'est rattrapé à un balcon trois étages plus bas... sans dommage corporel. Il ne prendra aucun arrêt de travail pour éviter d'aggraver ses difficultés financières, mais il présentera dans la semaine qui suit des troubles du sommeil, des cauchemars avec reviviscence nocturne de ce traumatisme, une recrudescence de l'angoisse, de l'irritabilité et des idées de référence.

C'est dans ce contexte que vont se développer des hallucinations acoustico-verbales : il entend des voix, uniquement masculines, qui l'injurient, le traitent de lâche, insultent sa femme qui n'est qu'une « salope », une « putain » et qui le « somment de divorcer ».

Il est totalement envahi par les hallucinations, d'abord dans le RER, ce qui l'oblige fréquemment à descendre avant sa station, puis sur son lieu de travail, où il interrompt sa tâche pour vérifier *qui parle*, à son domicile enfin.

Se sentant menacé, il se barricade chez lui, ne dort plus, enferme sa femme et ses enfants dans une pièce et défend son espace privé en donnant de nombreux coups de couteau dans la porte d'entrée, localisant les injures et les insultes sur le palier. Ce sont ces troubles du compor-

tement et sa crainte vis-à-vis de sa propre violence qui l'ont amené à consulter.

Il refusera l'hospitalisation dans un premier temps parce que sa femme n'est pas prévenue, et que sa famille est dépendante de lui (difficultés linguistiques, cours d'alphabétisation). Il m'explique qu'il les a fait venir il y a un an. Il parle de sa femme et de ses trois filles (14 ans, 11 ans et un bébé de 4 mois) avec beaucoup de chaleur et d'émotion, de ses difficultés à les faire vivre correctement, de son angoisse vis-à-vis de la dernière (il n'a pas connu les deux aînées lorsqu'elles étaient nourrissons), me propose de s'organiser (faire les courses pour la semaine, les confier à la voisine) et de revenir le lendemain pour se faire hospitaliser. Il viendra comme promis, et il est important de noter que M. S. a toujours tenu parole.

Sur le plan biographique, il est fils unique. Son père travaillait comme maçon, mais *il savait tout faire*, en particulier la peinture. Après avoir échoué au certificat d'études, M. S. est placé par le père comme apprenti menuisier, métier qu'il pratiquera durant trois ans. M. S. dit avoir été jaloux de son père qui effectuait souvent du travail de peinture, et s'être senti attiré par les *couleurs*. C'est à l'occasion d'un chantier en Corse, dont un ami de la famille était responsable, que M. S. décide de rester en France. Il s'installe dans la région parisienne, il a alors 22 ans et débute comme peintre en bâtiment.

Depuis, il travaille toujours dans la même entreprise, a appris son métier sur le tas, avec des peintres professionnels. Il retourne chaque année en vacances au Maroc et se marie en 1974. Sa femme habite dans la même rue

que ses parents. «Elle est rentrée dans mon cœur», dit-il, et il insiste sur le fait que ce n'est pas un mariage arrangé.

Il a successivement deux filles (la troisième est née en France). Il envoie tous les mois 150 € à sa femme et décide de la faire venir lorsqu'il aura trouvé un appartement correct.

Il habite pour sa part dans un foyer, le même depuis son arrivée en France, en partie payé par l'employeur. Avec un salaire d'un peu moins de 1 000 €, il dit bien vivre. En 1982, il trouve un appartement dont il paiera le loyer pendant six ans *pour rien*, préférant habiter au foyer, pour les copains, en attendant que sa famille régularise sa situation et puisse le rejoindre en France.

Très vite, donc, M. S. parle de ses difficultés à faire vivre sa famille, de ses difficultés au travail en particulier, de son angoisse depuis leur arrivée. C'est au fur et à mesure des entretiens qu'il fera le lien entre son discours délirant où *on le somme de divorcer*, où *on se met entre lui et sa femme*, et ses difficultés dans la situation concrète de travail, reprenant progressivement à son compte ce *on* étranger qui le persécute. Difficultés que je pourrais résumer par la souffrance issue de la contradiction entre :

- d'une part, des contraintes psychiques liées à l'organisation du travail qui nécessitent une coopération défensive virile, une reconnaissance par le collectif, et ce y compris en dehors de la situation de travail ;

- d'autre part, des contraintes psychiques sous-tendues par sa vie familiale : reprise du désir individuel vis-à-vis de sa femme et de ses filles, le mettant en difficulté avec l'idéologie défensive de la virilité entre

hommes qui jusque-là lui avait permis de faire face aux contraintes psychiques de son travail.

M. S. a longuement parlé de son travail : *ce métier je l'aime, je ne l'aime pas*, il insiste en particulier sur la différence entre chantier d'intérieur et chantier d'extérieur. À propos des chantiers d'extérieur :

– « C'est dangereux, y a le vertige, le froid, ça glisse ; mais ce qui donne du courage, c'est les autres. C'est parce qu'on est quatre ou cinq gars. Y en a toujours un pour descendre le premier. S'il y en a un qui a trop peur, on gueule dessus pour qu'il descende. On ne peut pas travailler seul. »

Lui descendait le premier, blaguait, commandait souvent. Il était apprécié des équipes, se voyait fréquemment confier le statut de chef de chantier s'il s'agissait d'un petit chantier ou si le chef était absent (Damien Cru *et al.*, 1983). Il payait les tournées. « On se raconte dans les bistrots », dit-il. C'étaient ces conditions de travail, et particulièrement le rapport au risque, qui structuraient sa vie (espace, temps) en dehors du travail. Il m'exposait ainsi, au fil des entretiens :

– la peur surgissant au cours des chantiers de ravalement, la confrontation permanente au risque d'atteinte de l'intégrité corporelle, voire de mort ;

– l'anxiété qui est à l'origine des comportements de défi grâce auxquels on peut penser qu'on maîtrise le risque ;

– le fonctionnement de *stratégies collectives de défense*, l'importance d'une confiance mutuelle et d'une cohésion du collectif pour pouvoir travailler (Dejours, 1980).

Mais peu à peu la situation de travail de M. S. va changer : en premier, dans l'organisation même du travail, entraînant une rupture des relations de confiance et de la coopération entre les ouvriers. Depuis deux ans, c'est « le fils du patron » qui a repris la direction de l'entreprise familiale. Le patron était lui-même ouvrier du bâtiment et connaissait donc le travail (tâche concrète) et ses employés, leur pratique, leur qualification. « Le fils, lui, n'y connaît rien, il a fait des études de gestion », dit M. S. Il ne fait aucune différence entre ses ouvriers, demande à ce que les cadences soient augmentées, place les gens indépendamment de leur qualification (chantier intérieur, extérieur).

– « Maintenant, c'est lui le patron. Avant c'était le chef de travaux avec qui on s'arrangeait directement. Quand le jeune est arrivé, il y avait des ouvriers qui avaient de bonnes relations avec lui. Ils ont été nommés aux postes de responsabilité. C'est plus pareil. Y a le téléphone rouge, à savoir des mouchards. »

Les gens sont menacés, convoqués dans le bureau : il y a donc des « gens qui parlent » ; première brèche dans ce collectif de travail et dans le fonctionnement de la stratégie défensive. M. S. insiste sur la disparition de la convivialité quotidienne, la cohésion se faisant dès lors contre les « mouchards » non identifiés.

M. S. s'est trouvé de plus en plus seul face au risque dans son travail. L'arrivée de sa famille à cette même époque et la naissance de sa troisième fille exacerbent les difficultés psychologiques.

Au bout de quelques mois de transition où il continuait à voir « les copains », il s'est acheté une montre pour

rentrer « à l'heure » à la maison. Sa famille, son désir personnel structuraient de plus en plus sa vie hors travail, et non plus le collectif déjà ébranlé par une organisation du travail différente. Il ne partage plus la vie des autres ouvriers. *On* se moque gentiment de lui : « C'est métro-boulot-dodo. »

Il n'arrive plus à commander. Il est en porte-à-faux parce qu'il n'est plus soutenu par l'idéologie défensive de métier. Il doit désormais seul faire face au danger (crainte de mort, angoisse face aux responsabilités vis-à-vis de sa famille).

Il s'ensuivra, dans ce climat d'isolement progressif, un accident du travail qui aurait pu être mortel, puis une crise psychique où, devant une situation impossible à gérer, les *hallucinations* lui conseillent de divorcer, ce qui lui permettrait de réintégrer le collectif de travail.

Pour tenter de faire face, il boit, mais seul cette fois.

L'autre solution, se précisant progressivement au cours des entretiens, est un travail à moindre risque, même si cela doit occasionner des remaniements dans son appartenance sociale et son identité.

« À l'intérieur il fait trop chaud, mais au moins c'est propre. On ne se salit pas. C'est pas de la barbouille comme le ravalement. Dehors, c'était trop dangereux. »

Cette histoire a donc pris sens (a été perlaborée, dirions-nous en termes plus techniques) à partir de l'interprétation des contradictions entre les contraintes de travail et les investissements affectifs de sa vie privée, *dans la situation actuelle*. Ce travail d'interprétation est sensiblement différent de celui que l'on fait usuellement en psychiatrie lorsqu'on ne tient pas compte du contexte

des rapports sociaux de travail actuels et que l'on ne fait référence qu'à la diachronie et à l'histoire psychonévrotique du patient à partir de son passé infantile (Ludwig Binswanger, 1958). De fait, en pratique, la rétrocession des troubles psychotiques a été obtenue sans traitement neuroleptique. La stabilisation mentale a été acquise en agissant uniquement sur la situation de travail, précisément grâce à un changement de poste de travail, dont les caractéristiques ont été mises au point par M. S. lui-même (chantiers d'intérieur) au cours d'un travail psychothérapique qui n'aurait probablement pas conduit à ce résultat sans la référence à la psychopathologie du travail.

Bibliographie

- BINSWANGER L., *Le cas Suzanne Urban. Étude sur la schizophrénie*, Paris, Desclée de Brouwer, 1958.
- CRU D. *et al.*, « Les savoir-faire de prudence dans les métiers du bâtiment. Nouvelle contribution de la psychopathologie du travail à l'analyse des accidents et de la prévention dans le bâtiment », *Les Cahiers médico-sociaux*, Genève, 1983, 27, 239-247.
- DEJOURS C., *Travail, usure mentale. Essai de psychopathologie du travail*, Paris, Le Centurion, 1980 (4^e éd., Paris, Bayard, 2005).